



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PENGEMBANGAN MODEL KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA MELALUI PEMBERDAYAAN TEMAN SEBAYA

(MODEL DEVELOPMENT ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH WITH PEERS EMPOWERMENT)

Heny Astutik
Roni Yuliwar



**PENGEMBANGAN MODEL KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA MELALUI PEMBERDAYAAN TEMAN SEBAYA
(*MODEL DEVELOPMENT ADOLESCENT
REPRODUCTIVE HEALTH WITH PEERS
EMPOWERMENT*)**

Penulis:

Dr. Heny Astutik, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dr. Roni Yuliwar, S.Kep., Ns., M.Ked.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pengembangan Model Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Pemberdayaan Teman Sebaya (*Model Development Adolescent Reproductive Health With Peers Empowerment*)

Penulis: Dr. Heny Astutik, S.Kep.Ns., M.Kes
Dr. Roni Yuliwar, S.Kep.Ns., M.Ked

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-22-1

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Pengembangan model kesehatan reproduksi remaja melalui pemberdayaan teman sebaya : Model development adolescent reproductive health with peers empowerment / penulis, Dr. Heny Astutik, S.Kep.Ns., M.Kes, Dr. Roni Yuliwar, S.Kep.Ns., M.Ked

EDISI

Cetakan pertama, Februari 2025

PUBLIKASI

Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

DESKRIPSI FISIK

89 halaman ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7139-22-1

SUBJEK

Reproduksi manusia -- Remaja - Kesehatan dan kebersihan

KLASIFIKASI

612.6 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1189255>

PRAKATA

Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis & psikososial. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Remaja juga memiliki potensi untuk berkarya, menjadi pendidik sebaya dan sahabat remaja karena mereka lebih mudah diterima oleh kaum remaja.

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik. Di tangan remajalah terdapat arah masa depan bangsa ini. Namun melihat kondisi remaja saat ini, harapan remaja sebagai penerus bangsa yang menentukan kualitas negara di masa yang akan datang sepertinya bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Perilaku nakal dan menyimpang di kalangan remaja saat ini cenderung mencapai titik kritis. Telah banyak remaja yang terjerumus ke dalam kehidupan yang dapat merusak masa depan. Masa remaja merupakan masa yang kritis, bila tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, mereka akan terjebak dalam perilaku yang membahayakan.

Dengan diterbitkannya buku ini Pengembangan Model Kesehatan Reproduksi Remaja ini, kami berupaya membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan beserta jajarannya, sekolah-sekolah serta masyarakat yang peduli terhadap remaja untuk mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui pemberdayaan teman sebaya dengan membentuk pusat-pusat *peer educator* dengan harapan

informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi dapat diterima oleh remaja sehingga remaja bertanggung jawab atas kesehatan organ-organ reproduksinya dan mampu menjalankan fungsi reproduksi secara optimal. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan bagi pemberi pelayanan kesehatan remaja memahami dan menerapkan Model Kesehatan Reproduksi Remaja melalui pemberdayaan Teman Sebaya.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI	7
--	----------

A. Pengertian Kesehatan Reproduksi	7
B. Tujuan Kesehatan Reproduksi	8
C. Sasaran Kesehatan Reproduksi.....	8
D. Komponen Kesehatan Reproduksi	8
E. Kesehatan Reproduksi dalam siklus Hidup Perempuan	9
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesehatan Reproduksi	11
G. Hak-hak Kesehatan Reproduksi	15

BAB 3 MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REMAJA	21
--	-----------

A. Pengertian Model	21
B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	21
C. Model Pemberdayaan Perempuan dan Remaja	22
D. Jenis Model Pemberdayaan Perempuan dan Remaja	23
E. Upaya Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Remaja	28

BAB 4 PENDIDIKAN SEBAYA (PEER EDUCATION)	29
---	-----------

A. Pengertian Pendidikan Sebaya	29
---------------------------------------	----

B. Tujuan Pendidikan Sebaya	29
C. Keunggulan Pendidikan Sebaya.....	30
D. Proses Pendidikan Sebaya.....	32
E. Metode Pendidikan Sebaya	32

BAB 5 PENDIDIK SEBAYA (PEER EDUCATOR)35

A. Pengertian Pendidik Sebaya.....	35
B. Syarat Pendidik Sebaya	35
C. Pengetahuan yang perlu dimiliki Pendidik Sebaya....	36
D. Keterampilan yang perlu dimiliki Pendidik Sebaya.....	36
E. Persiapan Pendidikan Sebaya	38
F. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidik Sebaya	39
G. Kiat-kiat Keberhasilan Pendidik Sebaya	40

BAB 6 PENGEMBANGAN MODEL KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA MELALUI PEMBERDAYAAN TEMAN SEBAYA.....43

A. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja	43
B. Model Kesehatan Reproduksi Remaja	50
C. Model Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja di Puskesmas	51
D. Model Pemberdayaan Teman Sebaya (<i>Peer Empowerment</i>)	53
E. Pengembangan Model Pemberdayaan Teman Sebaya (<i>Peer Empowerment</i>) dalam Kesehatan Reproduksi Remaja	57

BAB 7 PEDOMAN IMPLEMENTASI MODEL61

A. Tahapan Implementasi Model	61
B. Sarana dan Prasarana.....	63
C. Hasil Implementasi Model.....	64

BAB 8 PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
GLOSARIUM	77
PROFIL PENULIS	79

BAB 1

PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. tetapi dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya (ICPD, 1994). Dengan demikian kesehatan reproduksi dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman (Depkes.1997). Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja.

Jhon Pieget, (dalam Lapu, 2010) mengungkapkan, secara psikologi masa remaja adalah usia saat individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia saat anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis dan psikososial.

Pencarian jati diri seseorang terjadi pada masa remaja, namun dimasa remaja seseorang dapat terjerumus ke dalam kehidupan yang dapat merusak masa depan, apabila remaja melakukan hal-hal menyimpang yang biasa disebut dengan kenakalan remaja.

Sikap dan perilaku remaja dikenal sebagai masa yang penuh dengan eksperimental (keinginan untuk mencoba), rasa

keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului dengan pertimbangan yang matang (Depkes,2001). Hal ini menyebabkan remaja cenderung berperilaku beresiko baik secara fisik maupun psikis seperti hubungan seksual pranikah (4,7% laki-laki dan 3,2% perempuan) (LDFEUI, 1999). Penelitian lain tentang perilaku beresiko pada remaja ialah perilaku seksual, dalam penelitian yang dilakukan di kota Malang didapatkan data 7% remaja mengaku melakukan oral seks, hal ini dilakukan karena remaja mendapatkan inspirasi dari menonton VCD, film porno dan situsinternet (BKKBN, 2002). Perilaku hubungan seksual pranikah dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga cenderung melakukan aborsi. Tingkat aborsi di Indonesia diperkirakan sekitar 2 juta sampai 2,6 juta kasus pertahun, (30%) diantaranya dilakukan oleh penduduk berusia 15-24 tahun (BKKBN, 2005). Aborsi yang dilakukan remaja mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa, karena remaja lebih banyak melakukan aborsi yang tidak aman. Akibat lain hubungan seksual pranikah adalah tingginya infeksi HIV/AIDS dikalangan remaja dapat dilihat pada angka kejadian HIV/AIDS sampai dengan bulan September 2004 dilaporkan sebanyak 5.701 kasus, dan (50%) kasus yang terbanyak adalah pada kelompok umur 20-29 tahun.

Hasil penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tentang persepsi seks bebas dan kesehatan reproduksi remaja SMU se-DKI Jakarta tahun 2002 menunjukkan 37% responden wanita tidak mengetahui fungsi organ reproduksi pria, 36% responden pria tidak mengetahui fungsi organ reproduksi wanita, dan sebesar 34% tidak mengetahui apa itu penyakit menular seksual (PMS), sedangkan sumber informasi seks yang

utama bagi remaja SMU ini adalah TV dan majalah (39%). Sementara hasil penelitian Eirene, dkk (2012) tentang persepsi remaja tentang seks bebas pada siswa SMUN di Kota Malang dengan 100 responden didapatkan 41 % remaja laki-laki memiliki persepsi negatif, sedangkan remaja putri 15%.

Dari data sederhana diatas didapatkan bahwa ketidaktahuan remaja pelajar tentang HIV/AIDS, siklus dan reproduksi sehat serta penyakit menular seksual adalah akibat informasi yang sering salah disamping adanya pergeseran nilai dan perilaku seks ke arah seks bebas terutama di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya perlindungan, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ke arah kelompok ini secara intensif dan komprehensif.

Berbagai bentuk pendidikan kesehatan telah dilakukan selama ini khususnya berkaitan dengan AIDS, terbanyak dilakukan secara tidak langsung antara lain melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak, juga dilakukan secara langsung baik melalui ceramah maupun metode diskusi. Hasil penelitian Budisuari dan Arifin (2005), menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja masih dilakukan oleh guru dan petugas kesehatan (Puskesmas) yang dilakukan 1 kali setahun karena keterbatasan waktu, sedangkan penyuluhan oleh guru dilakukan disekolah melalui bimbingan konseling pada remaja setingkat SMA. Penyuluhan bagi remaja SMP belum dilakukan dengan alasan guru SMP kurang tepat untuk menjelaskan materi kesehatan reproduksi bagi remaja SMP karena masih berusia muda dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi khusus bagi remaja SMP. Kebaikan dari model ini adalah sosialisasi kesehatan reproduksi remaja sudah dilakukan oleh Puskesmas di sekolah-sekolah yang diintegrasikan dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah, penyediaan layanan kesehatan reproduksi remaja di

Puskesmas dan pelatihan remaja sebaya, namun beberapa kelemahan model ini adalah penyuluhan tidak bisa dilakukan secara intensif oleh Puskesmas karena keterbatasan waktu yaitu 1 kali dalam 6 bulan sampai 1 tahun, pengetahuan guru tentang kesehatan reproduksi masih kurang, waktu yang terbatas untuk memberikan konseling tentang kespro, guru merasa kurang tepat memberikan materi tentang kespro remaja dan keengganan remaja untuk berkunjung ke Puskesmas karena anggapan bahwa puskesmas tempat orang sakit. Hal ini menyebabkan tidak adanya perubahan pengetahuan maupun sikap remaja tentang kesehatan reproduksi.

Berdasarkan hasil survey jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Malang semakin banyak dari tahun ke tahun, begitu juga penderita pada kelompok umur remaja. Data tahun 2010 terdeteksi 294 kasus baru, sedangkan tahun 2011 ditemukan 385 kasus baru HIV/AIDS (Dinkes Kota Malang, 2012). Bertitik tolak kepada hal tersebut pendekatan Peer Education (pendidikan sebaya) diharapkan akan lebih berhasil. Melalui metode pelatihan dan pendidikan sebaya ini juga diharapkan terbinanya kelompok-kelompok motivator tentang kesehatan reproduksi remaja dan penanggulangan HIV/ AIDS. Pendekatan pendidikan sebaya sangat bermakna kolektif, komunikasi lebih lancar dan memungkinkan terjadi perubahan sikap di kalangan remaja untuk pencegahan HIV/AIDS dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Tabunya pendidikan seks dikalangan tertentu, membutuhkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang benar, tepat dan efektif. Melalui jalur pendidikan sebaya secara simultan untuk kalangan mahasiswa, pelajar dan remaja pada umumnya diharapkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS dapat diperoleh remaja, karena melalui pendidik sebaya (peer educator) pesan-pesan sensitif dapat disampaikan

secara lebih terbuka dan santai, informasi lebih mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang kurang lebih sama, dan orang lebih mudah mengemukakan pikiran dan perasaannya pada teman sebayanya (Widyantoro dan Lestari, 2003). Metode pendekatan pendidikan sebaya dalam rangka penanggulangan yang dimaksud adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang atau kelompok orang yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS, PMS dan masalah kesehatan reproduksi lainnya dengan pemberdayaan teman sebaya (peer educator). Pendidikan kelompok sebaya dilaksanakan antar kelompok sebaya tersebut dengan dipandu oleh fasilitator yang juga berasal dari kelompok itu sendiri, sehingga diharapkan lebih efektif.

BAB 2

KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI

A. Pengertian Kesehatan Reproduksi

United Nations, (1994) menjelaskan kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi berarti bahwa orang dapat memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman, serta memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk memutuskan apakah, kapan, dan seberapa sering hal itu dilakukan. Terkandung dalam kondisi terakhir ini adalah hak pria dan wanita untuk diberi informasi dan memiliki akses terhadap metode perencanaan keluarga yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sesuai pilihan mereka, serta metode lainnya yang sah untuk pengaturan kesuburan, dan hak akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai yang memungkinkan wanita menjalani kehamilan dan persalinan dengan aman serta memberikan pasangan kesempatan terbaik untuk memiliki bayi yang sehat.

Sesuai dengan definisi kesehatan reproduksi di atas, pelayanan kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai kumpulan metode, teknik, dan layanan yang berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan reproduksi dengan mencegah dan mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Ini

juga mencakup kesehatan seksual, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan dan hubungan pribadi, dan bukan hanya konseling dan perawatan terkait reproduksi serta penyakit menular seksual.

B. Tujuan Kesehatan Reproduksi

Tujuan utama dari kesehatan reproduksi adalah memberikan layanan kesehatan yang menyeluruh kepada setiap individu dan pasangannya, terutama kepada remaja, agar setiap orang dapat menjalani proses reproduksinya dengan sehat dan bertanggung jawab, serta terhindar dari diskriminasi dan kekerasan (Galbinur et al., 2021).

C. Sasaran Kesehatan Reproduksi

Menurut Maryam et al., (2021) terdapat dua sasaran Kesehatan Reproduksi yang akan dijangkau dalam memberikan pelayanan, yaitu:

1. Sasaran utama:

- a. Laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah
- b. Komponen Kesehatan Reproduksi Remaja: Seksualitas, beresiko/menderita HIV/AIDS dan beresiko dan pengguna NAPZA.

2. Sasaran antara:

- a. Petugas kesehatan: Dokter Ahli, Dokter Umum, Bidan, Perawat, Pemberi Layanan Berbasis Masyarakat
- b. Masyarakat: kader Kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

D. Komponen Kesehatan Reproduksi

1. Kesehatan Seksual: Kesejahteraan individu yang berkaitan dengan seksualitas mereka, termasuk kemampuan untuk

- memiliki pengalaman seksual yang menyenangkan dan aman, bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan
2. Perencanaan Keluarga: Kemampuan untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah, waktu, dan jarak kelahiran anak melalui akses terhadap metode kontrasepsi yang aman dan efektif
 3. Kesehatan Maternal: Kesehatan wanita selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, memastikan akses ke perawatan dan dukungan yang aman.
 4. Pencegahan dan Pengelolaan Masalah Kesehatan Reproduksi: Penanganan dan pengobatan masalah seperti infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS, dan gangguan kesehatan reproduksi lainnya.
 5. Hak Reproduksi: Hak individu untuk membuat keputusan yang diinformasikan tentang kesehatan reproduksi mereka, termasuk akses ke pendidikan, layanan, dan sumber daya untuk melindungi kesehatan dan otonomi mereka
 6. Kesehatan Reproduksi Remaja: Memastikan bahwa remaja, terutama yang berusia muda, memiliki akses ke informasi dan layanan yang sesuai dengan usia untuk kehidupan seksual dan reproduksi yang sehat
 7. Kesetaraan Gender: Mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi dan hak untuk membuat pilihan reproduksi mereka sendiri.

E. Kesehatan Reproduksi dalam siklus Hidup Perempuan

Konsep kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan (*life-cycle approach*) atau pelayanan kesehatan reproduksi

dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur (from womb to tomb) atau biasa juga disebut dengan "*Continuum of care women cycle*".

Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan hal ini disebabkan status kesehatan perempuan semasa kanak-kanak dan remaja mempengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi yaitu saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang dialami sepanjang hidup perempuan merupakan akar masalah yang mendasar yang menyebabkan buruknya kesehatan perempuan saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Tingkat pendidikan, kualitas dan kuantitas makanan, nilai dan sikap, sistem kesehatan yang tersedia dan bisa diakses, situasi ekonomi, serta kualitas hubungan seksualnya mempengaruhi perempuan dalam menjalankan masa reproduksinya (Eneng Daryanti & Lina Marlina, 2021).

Tabel 2.1 Siklus Hidup Perempuan (Matahari, 2018)

Masa Konsepsi	Masa setelah bersatunya sel telur dengan sperma kemudian janin akan tumbuh menjadi morulla, blastula, gastrula, neurulla yang akhirnya menjadi janin dan dengan terbentuknya placenta akan terjadi interaksi antara ibu dan janin
Masa bayi dan anak	Masa bayi dan anak adalah masa per-tumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima
Masa Remaja	Masa remaja pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah tumbuhnya rambut kemaluan (pubeshe), buah dada mulai tumbuh (thelarche), pertumbuhan tinggi badan yang cepat (maximal

	growth), mendapatkan haid yang pertama kali (menarche)
Masa Reproduksi	Masa dimana perempuan menjalankan tugas kehidupannya yaitu mulai hamil, melahirkan, masa nifas dan menyusui dan masa antara yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi
Masa Usia Lanjut	Masa usia lanjut yaitu masa dimana hormone estrogen sudah mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormone estrogen akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada perempuan diantaranya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh dan turunya massa tulang (osteoporosis)

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesehatan Reproduksi

Menurut (Zahan, 2014), faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi adalah:

1. Faktor biologis

Meskipun seksualitas manusia memiliki banyak fungsi selain reproduksi, dasar biologisnya tetap menjadi elemen fundamental dalam pengalaman seksual. Respon seksual melibatkan pemrosesan informasi secara psikologis, yang dipengaruhi oleh pembelajaran, respon fisiologis, dan mekanisme otak yang menghubungkan pemrosesan informasi dengan respon fisiologis.

Meskipun masih banyak yang belum sepenuhnya dipahami tentang rangkaian kompleks ini, diketahui bahwa individu memiliki kemampuan yang sangat

bervariasi dalam respon fisik dan seksual. Variabilitas ini hanya dapat dijelaskan sebagian oleh faktor budaya.

- a. Usia: Remaja dan usia lanjut lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi.
- b. Kesehatan umum: Penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi dapat memengaruhi fungsi reproduksi.
- c. Kondisi khusus: cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dsb.
- d. Status hormonal: Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan gangguan reproduksi, seperti infertilitas atau menstruasi tidak teratur.

2. Faktor ekonomi: kemiskinan

Kemiskinan, tentu saja, memengaruhi kesehatan secara maksimal, bukan hanya pada perempuan. Terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh tidak memiliki cukup makanan atau jenis makanan yang tepat, tidak memiliki rumah yang layak, pasokan air, dan sanitasi. Ketika tidak dapat memperoleh perawatan kesehatan yang dibutuhkan, kondisi ini akan semakin memperburuk situasi dengan efisiensi yang mematikan, terutama bagi perempuan.

Perempuan miskin sering kali menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk memasak atau mempersiapkan makanan. Biasanya, mereka tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai, sehingga mereka terpaksa menerima pekerjaan apapun yang bisa mereka dapatkan. Akibatnya, kesehatan mereka dan keluarga mereka sangat terpengaruh.

- a. Pendapatan: Kemampuan finansial memengaruhi akses ke layanan kesehatan reproduksi.
- b. Akses ke fasilitas: Daerah terpencil sering kekurangan layanan kesehatan reproduksi yang memadai.

3. Faktor demografik

Faktor demografi memengaruhi kesehatan perempuan dalam dua cara. Pertama adalah dampak pada tingkat "**makro**" yang merujuk pada seluruh masyarakat, dan yang kedua adalah dampak pada tingkat "**mikro**" yang mengacu pada individu atau keluarga.

Pada tingkat makro, pertumbuhan populasi yang terus berlanjut memberikan tekanan pada lingkungan yang membuat kehidupan kita semakin sulit, karena jumlah penduduk terus meningkat. Namun, tidak ada peningkatan pada penyediaan makanan, air, sanitasi, pendidikan, dan peluang kerja. Akibatnya, dampak dari kondisi ini paling dirasakan oleh perempuan miskin.

Pada tingkat mikro, keputusan mengenai ukuran keluarga dibuat oleh setiap pasangan. Peluang yang mereka miliki, seperti pendidikan, pekerjaan, dan lainnya, dapat menjadi salah satu penentu utama bagi kesehatan seorang perempuan dan keluarganya sepanjang hidup mereka.

4. Faktor Komunitas

Ketika suatu komunitas yang didefinisikan oleh budayanya juga memiliki status minoritas, anggotanya berpotensi menjadi objek bias ekonomi atau sosial yang dapat berdampak negatif pada kesehatan seksual.

Ketidaksetaraan ekonomi, dalam bentuk terbatasnya peluang pendidikan dan pekerjaan, serta kemiskinan yang sering kali menyertainya, memiliki dampak yang jelas terhadap akses dan penerimaan pendidikan serta perawatan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, dalam beberapa kasus, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap upaya kesehatan masyarakat di beberapa komunitas minoritas.

5. Faktor Budaya

Budaya bersama yang didasarkan pada nilai dan praktik merupakan bentuk komunitas lainnya. Setiap komunitas ini memiliki norma dan nilai tentang seksualitas, dan norma serta nilai ini dapat memengaruhi kesehatan seksual dan perilaku seksual anggotanya. Sebagai contoh, larangan kuat terhadap hubungan seksual di luar pernikahan dapat memiliki efek perlindungan terhadap infeksi IMS/HIV dan kehamilan remaja.

- a. Norma budaya: Pandangan budaya mengenai pernikahan, kehamilan, dan penggunaan alat kontrasepsi memengaruhi kesehatan reproduksi.
- b. Pendidikan: Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat menyebabkan perilaku berisiko.
- c. Stigma: Isu-isu seperti kehamilan di luar nikah atau penyakit menular seksual sering kali dikaitkan dengan stigma sosial.

6. Faktor politik

Untuk waktu yang lama, peran perempuan dalam kegiatan pembangunan tidak diakui. Terutama pekerjaan rumah tangga mereka, termasuk menyiapkan makanan dan merawat anak, karena pekerjaan tersebut tidak dibayar. Namun, saat ini para pembuat kebijakan menyadari bahwa pekerjaan perempuan, baik yang dibayar maupun tidak, memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan. Berbagai kebijakan memiliki dampak langsung pada status perempuan dan kesehatan mereka.

7. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan memiliki dampak langsung pada kesehatan perempuan. Perempuan miskin sering kali tidak

mendapatkan fasilitas yang diperlukan, yang secara tidak langsung berdampak pada kesehatan mereka. Karena keterbatasan fasilitas, mereka tidak dapat memasak makanan dengan baik dan sering kali tidak memungkinkan untuk merebus air minum. Akibatnya, perempuan menghadapi berbagai masalah penyakit. Penyakit dan infeksi di negara berkembang sering kali disebabkan oleh air yang tidak aman dan sanitasi yang tidak memadai.

Selain itu, banyak perempuan miskin yang bekerja di pabrik dan perusahaan industri dapat terpapar bahan kimia berbahaya atau radiasi, yang menimbulkan risiko kesehatan serius bagi mereka dan janin yang dikandung. Di negara-negara berkembang, sebagaimana yang telah kita lihat, nutrisi yang baik atau kekurangan gizi menjadi faktor utama dalam banyak hubungan melingkar antara perempuan, kesehatan, dan pembangunan.

Di banyak komunitas pedesaan, perempuan turut berpartisipasi dalam pekerjaan untuk memproduksi makanan keluarga, serta membawa air dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk menyiapkannya.

8. Faktor psikologis

Rasa rendah diri ("low self esteem"), tekanan teman sebaya ("peer pressure"), tindak kekerasan dirumah/ lingkungan terdekat dan dampak adanya keretakan orang tua dan remaja, depresi karena ketidak seimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasan secara materi.

G. Hak-hak Kesehatan Reproduksi

Hak reproduksi adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia yang berkaitan dengan kehidupan

reproduksinya. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menjamin agar hak-hak reproduksi individu tidak dilanggar dan dapat digunakan oleh setiap orang yang memiliki hak tersebut. Masyarakat juga berkewajiban membantu dan menghormati hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan Kesepakatan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 di Kairo, pemerintah Indonesia telah menyetujui 12 hak reproduksi yang di dalamnya termasuk hak-hak reproduksi perempuan:

1. Hak untuk hidup

Hak untuk hidup, yaitu hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Setiap perempuan hamil dan yang akan melahirkan berhak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk pelayanan kesehatan yang baik sehingga ia dapat mengambil keputusan secara cepat mengenai kelanjutan kehamilannya bila proses kelahirannya beresiko kematian atau terjadi komplikasi.

2. Hak mendapatkan kebebasan dan keamanan

Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi. Artinya setiap perempuan harus dijamin agar tidak mengalami pemaksaan, pengucilan, dan tekanan yang menyebabkan kebebasan dan keamanan yang diperolehnya tidak dapat digunakan, termasuk kebebasan memilih alat kontrasepsi yang dianggapnya paling aman.

3. Hak atas kesetaraan, dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi

Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan

reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk terbebaskan dari perlakuan diskriminasi berdasarkan gender/perbedaan jenis kelamin, ras, status perkawinan atau kondisi sosial-ekonomi, agama/keyakinannya dalam kehidupan keluarga dan proses reproduksinya. Misalnya, orang tidak mampu harus mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, demikian pula remaja yang hamil di luar nikah.

4. Hak privasi

Yakni hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya. Setiap perempuan berhak untuk dijamin kerahasiaan kesehatan reproduksinya, misalnya informasi tentang kehidupan seksualnya, masa menstruasi, jenis alat kontrasepsi yang digunakan.

5. Hak kebebasan berpikir

Hak untuk kebebasan berpikir tentang hak reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk mengungkapkan pikiran dan keyakinannya untuk menjaga kesehatan dan kehidupan reproduksinya tanpa paksaan dan siapa pun.

6. Hak atas informasi dan edukasi

Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan yang jelas dan benar tentang berbagai aspek terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, termasuk banyaknya pilihan alat kontrasepsi yang dapat dipilih oleh perempuan atau laki-laki dan efek samping dari berbagai alat kontrasepsi.

7. Hak memilih untuk menikah atau tidak serta untuk membentuk dan merencanakan sebuah keluarga

Yakni hak untuk membangun dan merencanakan sebuah keluarga. Setiap perempuan berhak untuk

menentukan kapan, di mana, dengan siapa, serta bagaimana ia akan membangun perkawinan atau keluarganya.

8. Hak untuk memutuskan apakah ingin dan kapan punya anak

Termasuk pula hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Setiap perempuan berhak untuk menentukan jumlah anak yang akan dilahirkannya serta menentukan jarak kelahiran anak yang diinginkannya, tanpa paksaan dari siapa pun.

9. Hak atas pelayanan dan proteksi kesehatan

Yakni hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan yang memadai bagi kehidupan reproduksinya, termasuk agar terhindar dari kematian akibat proses reproduksi, misalnya jaminan kesehatan agar perempuan terhindar dari kematian akibat kehamilan atau melahirkan. Hak ini tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan berdasarkan status perkawinan perempuan atau usia atau status ekonominya. Semua perempuan baik remaja, lajang, maupun yang berstatus menikah berhak untuk mendapatkan dan menikmati hak ini.

10. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan

Yakni hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi, misalnya informasi yang jelas dan benar serta

kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi baru.

11. Hak atas kebebasan berserikat berpartisipasi dalam arena politik

Yakni hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya mengenai kehidupan reproduksi secara pribadi atau melalui organisasi atau partai.

12. Hak untuk terbebas dari kesakitan dan kesalahan pengobatan

Yakni hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk , termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual dan kesalahan dalam pengobatan (malpraktek). Setiap perempuan berhak untuk dilindungi dari ancaman bentuk-bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis yang mengganggu kesehatan fisik, mental, dan reproduksinya dan terlindungi dari segala bentuk tindakan malpraktek.

Hak asasi perempuan mencakup hak mereka untuk mengendalikan dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa adanya paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam hal hubungan seksual dan reproduksi, termasuk penghormatan penuh terhadap integritas individu,

memerlukan rasa saling menghormati, persetujuan, dan tanggung jawab bersama atas perilaku seksual dan akibatnya.

Menurut (European Humanist Federation, 2015), Hak Seksual dan Reproduksi adalah hak setiap orang untuk:

1. Membuat keputusan tentang kesehatan seksual dan reproduksi mereka,
2. Hak untuk menikah dan menentukan jumlah, waktu, serta jarak kelahiran anak;
3. Hak atas keamanan seksual dan reproduksi yang bebas dari paksaan dan kekerasan;
4. Hak untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan keluarga berencana yang aman dan legal; serta
5. Hak untuk mengakses layanan kesehatan yang memungkinkan wanita menjalani kehamilan dan persalinan dengan aman

BAB 3

MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REMAJA

A. Pengertian Model

Model adalah perwujudan dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. (Achmad, M 2008).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2024), model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.

B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memper-kuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha memandirikan dan memampukan dengan

mendorong, memotivasi dan mem-bangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna (Afriansyah et al., 2023).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang mencerminkan suatu proses dimana individu, kelompok atau keomunitas diberikan kesempatan, pengetahuan, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan Keputusan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan (Hasdiansyah, 2023).

C. Model Pemberdayaan Perempuan dan Remaja

Salah satu pendekatan yang di terapkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis gender. Pendekatan gender dalam pemberdayaan masyarakat adalah kerangka kerja yang mengakui peran penting gender dalam memahami dan mengatasi ketidaksetaraan serta mempromosikan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi, pemahaman, dan penghapusan perbedaan gender, serta memberikan peran yang lebih aktif kepada perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender mereka. Pendekatan berbasis gender sangat berfokus pada pemberdayaan perempuan, termasuk pengakuan dan peningkatan peran serta kontribusi perempuan dalam semua bidang kehidupan. Hal ini mencakup akses yang lebih baik

terhadap pendidikan, pekerjaan yang setara, layanan kesehatan, keputusan politik, dan kendali terhadap sumber daya ekonomi (Siregar et al., 2022).

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Azizah, 2022).

D. Jenis Model Pemberdayaan Perempuan dan Remaja

Berikut beberapa model pemberdayaan perempuan dan remaja di Indonesia:

1. Pemberdayaan melalui pendidikan masyarakat

Model ini dianggap strategis untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, terampil, dan mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutisna, (2013), dimana tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan model pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender melalui layanan pendidikan masyarakat pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan metode survei, teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket, dan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut. (1) Layanan program pendidikan masyarakat yang paling banyak diikuti oleh responden adalah pendidikan kesetaraan (61,4%), dan jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah perempuan (75,8%). (2) Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender melalui pendidikan masyarakat (61,5%). (3) Model

pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender melalui pendidikan masyarakat, dipandang strategis dengan pengintegrasian berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah dengan program life skill sehingga akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri.

2. Pemberdayaan melalui keluarga

Pemberdayaan perempuan bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Dengan mendorong perempuan untuk menyadari potensi diri dan memaksimalkannya, perempuan dapat menjadi mitra seajar dalam keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurgina et al., 2023) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang mengenai program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), pelaksanaan programnya dan hasil dari program PEKKA terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dari adanya program PEKKA di kota Sukabumi berawal dari diadopsinya program Komisi Nasional Perempuan pada akhir tahun 2000. Namun di Kota Sukabumi program ini ditujukan untuk perempuan yang ingin berusaha dan berkembang untuk membantu penghasilan dalam keluarga baik perempuan yang berstatus janda atau yang masih memiliki suami dengan syarat tertentu. Pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Hasil dari program PEKKA terhadap peningkatan ekonomi keluarga yaitu meningkatkan taraf hidup, membangun kesadaran kritis, dan terpenuhinya kebutuhan keluarga.

3. Pemberdayaan melalui Desa Ramah Perempuan

Model ini mendorong dan mendukung pengorganisasian perempuan melalui berbagai kegiatan, seperti penyusunan peraturan desa yang mengakomodasi hak-hak perempuan.

Sutami et al., (2020) menjelaskan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor mempengaruhi implementasi program DRPPA. Faktor-faktor tersebut meliputi tujuan kebijakan yang jelas, sumber daya manusia yang berpengalaman, anggaran memadai, tetapi waktu pelaksanaan yang singkat. Komunikasi yang efektif terjalin antar organisasi pelaksana. Selain itu, badan pelaksana memiliki standar operasional prosedur yang jelas, dan relawan SAPA menunjukkan komitmen tinggi. Dukungan masyarakat, kondisi ekonomi yang perlu dioptimalkan, dan dukungan politik dari elite desa juga berperan penting.

Pemerintah Indonesia sangat mendukung program DRPPA ini, hal ini dibuktikan dengan telah dibuatkan payung hukum melandasi program tersebut yaitu Surat Keputusan Bersama antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 1 dan 329 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan Dan

Peduli Anak (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

4. Pemberdayaan melalui KIE

Model ini dimulai dari sumber informasi lembaga formal, seperti PKK, dan organisasi wanita. Melalui berbagai kegiatan dan gerakan, perempuan dapat menjadi mitra sejajar dalam keluarga.

Menurut Hasdiansyah, (2023), berikut beberapa contoh konkret pemberdayaan perempuan dengan pendekatan berbasis gender dalam berbagai konteks:

1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Sebuah organisasi non-pemerintah lokal bekerja untuk memberdayakan perempuan di daerah pedesaan dengan memberikan pelatihan dalam pertanian, produksi kerajinan tangan, atau kewirausahaan. Mereka juga membantu perempuan mengakses kredit mikro untuk mendukung usaha mereka sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan perempuan, memberikan mereka kendali atas sumber daya ekonomi, dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

2. Kurikulum Pendidikan Inklusif Berbasis Gender.

Sebuah sekolah atau sistem pendidikan mengembangkan kurikulum yang memasukkan bahan ajar yang tidak bias gender dan mencakup materi tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Ini membantu mengubah pandangan masyarakat tentang peran gender dan memberikan anak-anak pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu gender.

3. Pusat Penanganan Kekerasan Berbasis Gender.

Sebuah pusat krisis atau lembaga penanganan kekerasan berbasis gender menyediakan tempat aman

untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga memberikan konseling, bantuan hukum, dan dukungan psikososial kepada korban kekerasan. Tujuannya adalah melindungi perempuan yang rentan dan membantu mereka memulihkan diri.

4. Kampanye Kesadaran Kesehatan Reproduksi.

Sebuah LSM bekerja dengan komunitas lokal untuk menyelenggarakan kampanye pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Mereka memberikan informasi tentang kontrasepsi, perawatan prenatal, dan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Ini bertujuan untuk memberikan perempuan akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan reproduksi dan memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik tentang tubuh mereka sendiri.

5. Program Pelatihan Kepemimpinan Perempuan.

Sebuah organisasi yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan perempuan menyelenggarakan program pelatihan untuk perempuan yang tertarik dalam berkarier di bidang politik. Mereka memberikan keterampilan berbicara, manajemen kampanye, dan pemahaman tentang isu-isu politik. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan mengatasi ketidaksetaraan gender di dunia politik.

6. Inisiatif Media Berbasis Gender:

Sebuah stasiun televisi lokal berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang mencerminkan peran positif perempuan dalam masyarakat. Mereka juga melibatkan perempuan dalam berita dan diskusi tentang isu-isu penting. Ini membantu mengubah cara

masyarakat melihat perempuan dalam media dan mendorong perempuan untuk berbicara tentang isu- isu yang penting.

E. Upaya Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Remaja

Menurut Azizah, (2022) dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan,
- b. Meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan,
- c. Menargetkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemilu legislatif,
- d. Menerapkan wajib belajar 12 tahun,
- e. Meningkatkan angka melek huruf melalui program pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan,
- f. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap ibu dan anak, serta
- g. Memberikan edukasi bagi para ibu hamil dan calon orang tua untuk menggunakan penolong persalinan yang memiliki kualifikasi dan menyusui bayi selama dua tahun.

BAB 4

PENDIDIKAN SEBAYA (PEER EDUCATION)

Sebaya adalah seseorang yang memiliki kedudukan setara dengan orang lain dalam hal usia, latar belakang, status sosial, dan minat. Sebaya memainkan peran penting dalam perkembangan psikososial sebagian besar remaja. Mereka, pada kenyataannya, memberikan peluang untuk menjalin hubungan pribadi, perilaku sosial, dan rasa memiliki. Oleh karena itu, pendidikan sebaya dianggap sebagai strategi promosi kesehatan yang efektif pada remaja (Peykari et al., 2011).

A. Pengertian Pendidikan Sebaya

Pendidikan sebaya (*Peer Education*) adalah suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh dan untuk kalangan yang sebaya yaitu kalangan satu kelompok, ini dapat berarti kelompok sebaya pelajar, kelompok mahasiswa, sesama rekan profesi, jenis kelamin. Pendidikan sebaya dikenal sebagai berbagi informasi dan pengalaman di antara individu yang memiliki kesamaan tertentu (Sandhu et al., 2013).

B. Tujuan Pendidikan Sebaya

Tujuan pendidikan sebaya adalah membantu remaja dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk modifikasi perilaku positif melalui penyediaan dukungan preventif dan

psikososial yang mudah diakses dan terjangkau. Program pendidikan sebaya terutama berfokus pada informasi pengurangan dampak buruk, pencegahan, dan intervensi dini. Remaja menerima pendidikan sebaya sebagai strategi yang disukai untuk menjangkau populasi yang sulit dijangkau, seperti pekerja seks, serta untuk mendekati dan mendiskusikan topik-topik yang kurang dibahas atau dianggap tabu dalam konteks lain (Swartz et al., 2012).

C. Keunggulan Pendidikan Sebaya

1. Peningkatan Aksesibilitas Informasi

Pendidikan sebaya memudahkan penyampaian informasi karena dilakukan oleh individu yang memiliki kesamaan latar belakang, usia, atau pengalaman dengan penerima informasi. Hal ini menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan relevan (Elisa et al., 2022; Peykari et al., 2011). Menurut Widianoro *et al* (2002), metode pendidik sebaya menjadi metode pilihan dalam menyampaikan informasi karena pendidik sebaya menggunakan bahasa yang kurang lebih sama, sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh kelompok sebayanya.

2. Efektivitas dalam Mengubah Perilaku

Program pendidikan sebaya telah terbukti efektif dalam mengubah perilaku terkait isu-isu kesehatan, seperti pencegahan HIV/AIDS, penggunaan narkoba, dan kesadaran reproduksi (Mabuie, 2020).

3. Meningkatkan Partisipasi Remaja

Karena menggunakan pendekatan yang melibatkan kelompok sebaya, program ini lebih menarik bagi remaja dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan edukasi.(Nurmala et al., 2022).

4. Efisiensi Biaya

Pendidikan sebaya relatif hemat biaya karena memanfaatkan individu dari komunitas itu sendiri sebagai sumber daya manusia. Dengan berbagai kondisi sosial ekonomi dengan peserta program, pendidik sebaya dapat membuat materi pendidikan lebih mudah diakses dan kredibel bagi peserta, sehingga meningkatkan efektivitas program pendidikan sebaya (Ranjbar et al., 2024). Berbagai alasan finansial, intelektual, dan emosional menyebabkan pendidikan sebaya di kalangan remaja menjadi menarik. Selain itu, partisipasi relawan yang tidak dibayar membuat pendidikan sebaya menjadi lebih terjangkau (30).

5. Pemberdayaan Pendidik Sebaya

Selain memberikan manfaat kepada penerima pendidikan, program ini juga memberdayakan pendidik sebaya melalui peningkatan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan rasa percaya diri (Wawrzynski et al., 2011).

6. Fleksibilitas:

Model ini bisa diterapkan dalam berbagai konteks, seperti pendidikan kesehatan, pencegahan penyalahgunaan zat, pengembangan keterampilan sosial, dan pencegahan bullying di sekolah (*United Nations Population Fund*, 2005).

7. Keberlanjutan Program

Program pendidikan sebaya cenderung lebih berkelanjutan karena melibatkan individu lokal yang memahami kebutuhan komunitas mereka. UNAIDS (1999). *Peer Education and HIV/AIDS: Concepts, Uses, and Challenges*.

D. Proses Pendidikan Sebaya

1. Seleksi dan Pelatihan Pendidik Sebaya (Peer Educator)

Suksesnya program pendidikan teman sebaya bergantung pada pemilihan individu yang tepat untuk menjadi peer educator, serta pelatihan yang memadai untuk memastikan mereka dapat menyampaikan informasi dengan benar dan efektif.

2. Interaksi dan Dukungan Berkelanjutan

Setelah proses pelatihan, peer educator biasanya terus mendukung kelompok mereka dengan menyediakan informasi tambahan, menjawab pertanyaan, dan memberikan motivasi.

3. Evaluasi dan Refleksi

Penting untuk mengevaluasi program pendidikan sebaya (*peer education*) secara berkala untuk menilai efektivitasnya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan menyesuaikan pendekatan jika diperlukan

E. Metode Pendidikan Sebaya

Metode pendidik sebaya menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam pendidikan kesehatan. Metode pembelajaran lain yang biasa digunakan dalam pendidikan kesehatan antara lain ceramah, diskusi, demonstrasi, ceramah plus, resitasi, perlakuan, *study tour*, latihan keterampilan, pengajaran beregu, *problem solving method*, *project method*, *teileren method* dan *ganze method* (Simamora, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Lorenz & Permatasari, (2023) diperoleh informasi metode yang digunakan dalam pendidikan sebaya sangat beragam melalui ceramah, diskusi kelompok, kuis, sitkom, pesan edukatif melalui whatsapp dan media audio visual. Rentang durasi waktu yang digunakan

juga bervariasi, pendidikan sebaya dilakukan $\pm$ 1 tahun dengan metode permainan kuis pengetahuan, diskusi kelompok, pertunjukkan sitkom, pameran poster yang dirancang sendiri.

BAB 5

PENDIDIK SEBAYA (PEER EDUCATOR)

A. Pengertian Pendidik Sebaya

Seorang pendidik sebaya adalah anggota dari kelompok sebaya yang menerima pelatihan dan informasi khusus dan berusaha untuk mempertahankan perubahan perilaku positif di antara anggota kelompok tersebut (Mason-Jones et al., 2011).

B. Syarat Pendidik Sebaya

Untuk menjadi seorang peer educator, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut (Strange et al., 2002)(Al-Iryani et al., 2013):

1. Harus menerima pelatihan yang memadai yang memungkinkan mereka untuk memahami tujuan program.
2. Mengetahui sumber informasi dan konseling lainnya sehingga dapat merujuk teman sebaya mereka ke bantuan yang tepat.
3. Memiliki ciri-ciri kepribadian, antara lain: ramah, sabar, humoris, komunikatif, lancar dalam mengemukakan pendapat, luwes dalam pergaulan, berinisiatif dan kreatif, tidak mudah tersinggung, terbuka untuk hal-hal baru, mau belajar serta senang menolong, kepercayaan diri yang cukup, kasih sayang mampu menjadi pendengar

- yang baik, memberikan dorongan, motivasi, dan mendukung keputusan serta perilaku yang sehat.
4. Mempunyai keterampilan komunikasi interpersonal yang diterima oleh teman sebaya lainnya dengan ciri-ciri:
 - a. Mampu melakukan komunikasi dua arah,
 - b. Mampu melakukan komunikasi verbal dan non verbal,
 - c. Menggunakan pertanyaan untuk menggali informasi, perasaan dan pikiran,
 - d. Bersikap sebagai pendengar yang aktif
 - e. Tidak menghakimi dan memberikan respon positif
 - f. Memiliki sikap empati

C. Pengetahuan yang perlu dimiliki Pendidik Sebaya

1. Pengetahuan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi, meliputi: serba-serbi seksualitas, organ reproduksi dan fungsinya, tumbuh kembang remaja, proses terjadinya kehamilan dan bahaya kehamilan remaja, infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, metode kontrasepsi, narkoba dan isu-isu kesehatan reproduksi lainnya;
2. Pengetahuan kesehatan diri;
3. Informasi tentang tempat-tempat layanan kesehatan atau tempat rujukan lainnya;
4. Pengetahuan tentang hukum, agama dan peraturan/perundangan mengenai kesehatan reproduksi.

D. Keterampilan yang perlu dimiliki Pendidik Sebaya

Peer Educator atau Pendidik Sebaya harus memiliki keterampilan komunikasi interpersonal, yaitu hubungan timbal balik yang bercirikan:

1. Komunikasi dua arah
2. Perhatian pada aspek verbal dan non verbal

3. Penggunaan pertanyaan untuk menggali informasi, perasaan dan pikiran
4. Sikap mendengar yang aktif
5. Tidak menghakimi dan memberikan respon positif
6. Memiliki sikap empati

Komunikasi interpersonal adalah proses penyebaran dan berbagi informasi, pendapat, dan perasaan sekurangnya antara dua orang yang dilakukan secara langsung atau tatap muka.

Ada 5 aspek penting dari komunikasi interpersonal:

1. Komunikasi satu arah dan dua arah
2. Komunikasi verbal dan non verbal
3. Pertanyaan tertutup dan terbuka
4. Keterampilan mendengar efektif
5. Menggunakan alat bantu sederhana

Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan kata-kata. *Peer Educator* sebaiknya:

1. Menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh kelompok sebayanya.
2. Menghindari istilah yang sulit dimengerti (bahasa asing, terminologi medis)
3. Menghindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta.

Komunikasi Non Verbal adalah komunikasi yang disampaikan dalam bentuk kontak mata, nada suara, ekspresi wajah, dan gerakan anggota tubuh tertentu. Dalam menyampaikan informasi, *Peer Educator* sebaiknya menggunakan nada suara yang ramah, bersahabat dan lembut serta tetap mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara.

E. Persiapan Pendidikan Sebaya

Persiapan yang perlu dilakukan oleh Pendidik Sebaya (*Peer Educator*) dalam kegiatan pendidikan sebaya antara lain:

1. Persiapan pribadi

- a. Motivasi (keinginan) untuk melakukan kegiatan pendidikan sebaya sampai tuntas
- b. Bersedia menyisihkan waktu yang cukup, tidak ada keterpaksaan
- c. Berada dalam kondisi fisik dan emosi yang sehat
- d. Refleksi pengetahuan yang dimiliki khususnya kesehatan reproduksi

2. Persiapan tempat

- a. Pendidikan sebaya dapat dilakukan dimana saja asalkan nyaman buat Peer Educator dan kelompoknya.
- b. Kegiatan tidak harus dilakukan di ruangan khusus. Dapat dilakukan di teras masjid, dibawah pohon yang rindang, di ruang kelas yang tidak dipakai, di rumah peserta, dan sebagainya.
- c. Tempat tidak perlu luas, asal bersih. Sebaiknya tidak ada orang yang lalu lalang dan jauh dari kebisingan sehingga diskusi bisa berlangsung tanpa gangguan.
- d. Perhatikan penerangan dan sirkulasi udara
- e. Jika memungkinkan sediakan minuman dan makanan kecil untuk menambah semangat belajar.

3. Persiapan materi informasi

Pendidik sebaya sebaiknya mempersiapkan materi/bahan-bahan yang diperlukan sebelum memulai pertemuan, antara lain:

- a. Buku pengetahuan kesehatan reproduksi
- b. Buku panduan peer educator/pendidik sebaya

- c. Membaca kembali topik yang akan disajikan, baik dari buku panduan yang telah dimiliki maupun bacaan lainnya.
- d. Menyiapkan alat bantu sesuai topik yang akan dibicarakan, misalnya alat peraga, contoh-contoh kasus, kliping koran dan lain-lain.

F. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidik Sebaya

Langkah-langkah yang harus diperhatikan agar kegiatan pendidikan sebaya berjalan lancar :

1. Memilih peserta:

Peer educator memilih teman seusia yang berminat terhadap kesehatan reproduksi. Kegiatan ini ditujukan bagi peserta yang benar-benar berminat secara sukarela untuk mengikuti seluruh pertemuan yang telah disepakati. Hindari cara-cara pemaksaan.

2. Jumlah ideal peserta:

Pendidikan sebaya idealnya diikuti oleh 10 – 12 peserta agar setiap peserta mempunyai kesempatan bertanya. Bila peserta terlalu banyak, tanya jawab menjadi kurang efektif dan peserta tidak akan mendapatkan pemahaman serta pengetahuan yang cukup memadai.

3. Melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 6-8 kali (@ 2 jam):

Peer educator memulai acara dengan menyampaikan materi selama 30-45 menit, selebihnya digunakan untuk diskusi. Bila ada pertanyaan yang tidak mampu dijawab, jawaban ditunda untuk ditanyakan kepada mereka yang lebih ahli, bisa dokter, bidan, pemuka agama dan lain-lain.

4. Tempat dan waktu pertemuan

Tempat dan waktu pertemuan ditentukan bersama oleh peserta, dapat di rumah peserta, sekolah, puskesmas dan lain-lain.

5. Tempat duduk

Sebaiknya duduk dibuat melingkar agar setiap orang dapat saling memandang dan berbicara. Tujuan yang lain adalah untuk menunjukkan kesetaraan antar semua orang dan meningkatkan rasa nyaman.

G. Kiat-kiat Keberhasilan Pendidik Sebaya

Dalam kegiatan pendidikan sebaya, seorang *peer educator* perlu mempersiapkan dengan baik segala kebutuhan yang diperlukan termasuk persiapan diri agar kegiatan pendidikan sebaya berhasil. Berikut ini kiat-kiat menjadi pendidik sebaya yang berhasil, yaitu:

1. Bersedia untuk terus belajar dan memperluas wawasan
2. Rajin mencari informasi tambahan
3. Menyisipkan humor dalam pemberian materi
4. Kreatif mencari alat bantu untuk menghidupkan suasana pembelajaran
5. Mau menerima kritikan dan saran yang membangun
6. Membuat persiapan sebelum kegiatan pembelajaran
7. Menguasai materi
8. Melibatkan semua peserta dalam kegiatan pembelajaran
9. Menggunakan alat bantu
10. Berbicara dengan jelas dan lantang
11. Memancing pertanyaan dari peserta
12. Mengatur waktu dengan cermat
13. Duduk dalam lingkaran agar dapat memandang semua peserta
14. Menjaga kontak mata saat bicara

15. Memperhatikan bahasa tubuh peserta
16. Periksa apakah informasi sudah dimengerti oleh peserta
17. Bersikap sabar dan percaya diri
18. Peer educator jangan melakukan hal-hal berikut yaitu: mebelakangi peserta, Meremehkan komentar dan pendapat peserta, Membaca materi. Materi sebaiknya sudah dihafal dan dipahami, Berbicara dengan nada keras kepada peserta, Mudah marah bila peserta mengkritik atau memberi saran, Menggurui, Hanya melihat pada satu atau dua peserta saja dan Menilai dan menghakimi

BAB 6

PENGEMBANGAN MODEL KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA MELALUI PEMBERDAYAAN TEMAN SEBAYA

A. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja

Masa remaja adalah masa dimana anak sudah meninggalkan masa kanak-kanaknya menuju dunia orang dewasa. Batasan usia menurut WHO adalah usia 10-24 tahun., namun di Indonesia sendiri menurut Undang-Undang no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menetapkan definisi anak sebagai seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Batasan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pada usia inilah tercapai kematangan mental, pribadi dan sosial walaupun kematangan biologis sudah terjadi lebih awal pada waktu usia belasan tahun.

1. Definisi Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan Reproduksi remaja didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat jasmani, psikologis dan social yang berhubungan dengan fungsi dan proses system reproduksi pada remaja. Pengertian sehat tersebut tidak semata-mata berarti terbebas dari penyakit atau kecacatan namun juga sehat secara mental serta social cultural. Remaja adalah pemimpin bangsa masa depan, namun saat ini mereka menghadapi segumpalan masalah besar

yang dapat menentukan kualitas suatu bangsa di masa yang akan datang. Masalah-masalah seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, pelecehan, kekerasan, seksualitas dan pernikahan merupakan sebagian dari permasalahan yang dihadapi remaja yang memerlukan perhatian dari para peneliti, akademisi, aktivis, orang tua dan juga pembuat kebijakan. Dalam upaya mengatasi isu yang kompleks ini, tidak jarang kita dihadapkan pada kendala ketidakpedulian, kontroversi dan budaya (Widyantoro & Lestari, 2014).

2. Masalah-masalah Kesehatan Remaja

a. Masalah Gizi

- 1) Obesitas, biasa dikatakan badan gemuk, lebih banyak terjadi pada remaja perempuan daripada laki-laki, obesitas dapat memberikan pengaruh negative terhadap imajinasi diri.
- 2) Anemia karena kurang zat besi adalah masalah yang umum ditemui pada remaja perempuan akibat kekurangan zat besi. Remaja perempuan lebih banyak membutuhkan zat besi dibandingkan dengan laki-laki. Zat besidiperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah. Dikonversi menjadi hemoglobin, beredar keseluruh jaringan tubuh dan berfungsi sebagai pembawa oksigen.
- 3) Kurang energy kronis, terjadi pada remaja umumnya karena makan yang terlalu sedikit, remaja perempuan yang berat badannya menurun drastic erat kaitannya dengan factor emosioanal sepertitakut gemuk atau kurang seksi bila dipandang lawan jenis (Widyantoro & Lestari, 2014)

b. Masalah seks dan kesehatan seksualitas

Perkembangan seksual pada remaja ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Setelah seorang gadis mengalami menstruasi yang pertama dan mimpi basah pada laki-laki, maka sejak itu fungsi reproduksinya bekerja dengan segala konsekuensinya. Ketidaksiapan remaja menghadapi perubahan-perubahan dalam dirinya termasuk diantaranya menerima kenyataan dorongan seks mulai meningkat dan sulit dikendalikan. Nilai dan norma yang ada sudah mulai tidak dihiraukan lagi.

Situasi di atas diperburuk dengan terbatasnya akses remaja memperoleh informasi seks yang benar dan lengkap. Orang tua hingga saat ini masih sulit untuk menjadi kawan seiring remaja untuk masalah seksualnya. Karena masih banyak orang tua yang masih bingung akan apa yang harus diperbuat, kebingungan itu meliputi informasi apa yang pantas diberikan pada remaja, bagaimana cara memulainya dan lain-lain.

Upaya pemberian informasi seks sendiri di Indonesia masih banyak ditentang, bahkan di dunia Internasional pun masih merupakan perdebatan dua pandangan. Pandangan yang kurang setuju dengan pendidikan seks mengkhawatirkan bahwa pendidikan seks yang diberikan pada anak remaja akan mendorong mereka melakukan hubungan seks lebih dini (Widyantoro & Lestari, 2014)

c. Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja

Sejak tahun 1994, masalah remaja dibicarakan secara terbuka sebagai salah satu masalah kesehatan reproduksi di konferensi kependudukan di Kairo. Di

negara-negara berkembang salah satu penyebab masalah kesehatan reproduksi seperti angka kematian ibu yang tinggi diduga terkait erat dengan masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja. Antara lain karena masa transisi dari periode anak-anak ke orang dewasa berlangsung terlalu cepat di negara berkembang. Kematangan biologis remaja perempuan pedesaan (haid pertama) biasanya segera diikuti dengan perkawinan usia belia yang mengantarkan remaja perempuan pada risiko kehamilan dan persalinan. Hal ini berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan pada usia dini. Di sisi lain, kematangan biologis remaja laki-laki dan perempuan di perkotaan dibayang-bayangi kemungkinan lebih dininya usia pertama aktif seksual dan akibat kecacatan yang harus dialami (Kollmann, 1998). Kesehatan reproduksi sendiri seringkali berkaitan dengan resiko-resiko antara lain :

1) Perkosaan.

Perkosaan adalah tindakan persetubuhan (senggama) yang melanggar hukum dengan jalan memaksa atau menipu dan tanpa persetujuan. Definisi ini dapat diperluas dengan "berbagai lubang" dengan tujuan untuk mencakup penetrasi paksaan terhadap mulut ataupun anus. Korban perkosaan menjadi trauma oleh kejahatan seksual dan kekerasan. Tindakan perkosaan merupakan suatu pengalaman yang secara psikologis sangat menghancurkan yang dapat dialami oleh seseorang. Merupakan tindakan yang merampas identitas diri korban, serta perasaan ketakutan yang dapat

menetap lama setelah pasien memperoleh perawatan medis darurat.(Kapita Selekta,1994)

Kejahatan perkosaan ini biasanya banyak sekali modusnya. Korbannya tidak hanya remaja perempuan, tetapi juga laki-laki (*sodom*). Remaja perempuan rentan mengalami perkosaan oleh sang pacar, karena dibujuk dengan alasan untuk menunjukkan bukti cinta.

2) *Free sex*.

Seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacar yang berganti-ganti. Seks bebas pada remaja ini (di bawah usia 17 tahun) secara medis selain dapat memperbesar kemungkinan terkena infeksi menular seksual dan virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus), juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Sebab, pada remaja perempuan usia 12-17 tahun mengalami perubahan aktif pada sel dalam mulut rahimnya. Selain itu, seks bebas biasanya juga dibarengi dengan penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Sehingga hal ini akan semakin memperparah persoalan yang dihadapi remaja terkait kesehatan reproduksi ini.

3) Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Hubungan seks pranikah di kalangan remaja didasari pula oleh mitos-mitos seputar masalah seksualitas. Misalnya saja, mitos berhubungan seksual dengan pacar merupakan bukti cinta. Atau, mitos bahwa berhubungan seksual hanya sekali tidak akan menyebabkan kehamilan. Padahal hubungan seks sekalipun hanya sekali juga dapat menyebabkan kehamilan selama si remaja

perempuan dalam masa subur. Banyak survey yang dilakukan di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa hampir 60% kehamilan pada perempuan dibawah 20 tahun adalah kehamilan tidak diinginkan atau salah waktu (mistimed) (Widyantoro & Lestari, 2014)

4) Aborsi.

Aborsi merupakan keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya. Kehamilan yang tidak diinginkan sering kali berakhir dengan aborsi. Aborsi pada remaja terkait KTD biasanya tergolong dalam kategori aborsi provokatus, atau pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan. Namun begitu, ada juga yang keguguran terjadi secara alamiah atau aborsi spontan. Hal ini terjadi karena berbagai hal antara lain karena kondisi remaja perempuan yang mengalami KTD umumnya tertekan secara psikologis, karena secara psikososial remaja belum siap menjalani kehamilan. Kondisi psikologis yang tidak sehat ini akan berdampak pula pada kesehatan fisik yang tidak menunjang untuk melangsungkan kehamilan.

5) Perkawinan dan kehamilan dini.

Masih banyak ditemukan perempuan menikah dan melahirkan di usia remaja. Kehamilan dan persalinan membawa resiko kesakitan dan kematian yang lebih besar pada remaja dibandingkan pada perempuan yang telah berusia 20 tahunan, terutama di wilayah di mana pelayanan medis sangat langka atau tidak tersedia. Remaja perempuan berusia di bawah 18 tahun beresiko 2-5 kali terhadap kematian (*maternal mortality*) dibandingkan perempuan

berusia 18-25 tahun akibat persalinan lama dan persalinan macet, perdarahan maupun faktor lain. Kegawat daruratan akibat kehamilan, misalnya tekanan darah tinggi (hipertensi) dan anemia (kurang darah) juga lebih sering terjadi pada ibu-ibu berusia remaja, terutama pada daerah dimana kekurangan gizi merupakan endemis.

Untuk menangani kasus kehamilan remaja, petugas kesehatan harus bersikap bersahabat dan tidak menghakimi terhadap remaja, memberikan konseling pada remaja dan keluarganya, memberikan jalan keluar yang terbaik bila menemukan masalah yang serius dan mengkonsultasikan ke tenaga ahli (seperti SpOG, SpKK, psikolog atau psikiater) bila belum terselesaikan.

6) *Female Genital Mutilation (FGM)*

Adalah pemotongan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan maupun tindak perlukaan lainnya terhadap alat kelamin perempuan. FGM merupakan praktik tradisonal yang sudah berurat berakar yang berdampak sangat parah dan berat terhadap kesehatan reproduksi remaja putri atau perempuan. Umumnya praktik semacam ini dilakukan di negara-negara Afrika; sekitar 2 juta remaja putri menjadi korban praktik setiap tahunnya. Selain trauma psikologis yang dialami saat pemotongan, FGM dapat mengakibatkan infeksi, perdarahan hebat atau shock. Beberapa bentuk FGM dapat menyebabkan rasa sakit kronis setiap kali melakuakn hubungan seks, infeksi radang panggul yang berulang-ulang dan persalinan lama

dan macet. ICPD menyatakan bahwa FGM merupakan pelanggaran HAM dan mendesak penghapusan kebiasaan tersebut (Widyantoro & Lestari, 2014).

B. Model Kesehatan Reproduksi Remaja

Menurut WHO, beberapa hambatan utama untuk mempromosikan kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat berkembang secara optimal adalah:

1. Kurang adanya kebijakan dan program yang efektif dan kegagalan untuk melibatkan remaja dalam kegiatan prnorsi selama ini,
2. Remaja belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan diri mereka, terutama yang berkaitan dengan seksualitas, dan perubahan hubungan yang terjadi pada masa remaja, serta kurangnya adanya komunikasi tentang masalah yang dihadapi remaja dengan orang yang dapat dipercaya dalam rangka mengambil keputusan dan bertindak secara bertanggung jawab,
3. Kurangnya informasi tentang berbagai bahaya akibat dari penggunaan obat-obatan dan bahan narkotika serta penyakit menular seksual,
4. Remaja yang sudah mengetahui kebutuhan akan informasi dan pengetahuan, kurang memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena belum adanya informasi yang memadai di mana mereka dapat memperoleh pelayanan dan bantuan yang diperlukannya.
5. Pelayanan kesehatan yang tersedia masih belum dilengkapi peralatan hahan dan petugas yang terlatih serta rnemiliki keterampilan untuk mernberikan pelayanan pada remaja.

Sehubungan dengan itu WHO menganjurkan untuk:

1. Dilakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap kesehatan reproduksi remaja melalui pendekatan terpadu antar sektor dan disiplin sehingga kebutuhan kesehatan reproduksi remaja dapat terjamin secara optimal. Keterlibatan dan peran antara lain dari sektor-sektor seperti sektor pendidikan, agama, penerangan (mass media), ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga serta keluarga sangat penting untuk keberhasilan pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi remaja.
2. Program utama yang perlu dikembangkan adalah:
 - a. Mempromosikan kesehatan reproduksi remaja secara optimal sesuai kebutuhan remaja antara lain: -aspek fisik (nutrisi), -aspek psikologis (komunikasi), aspek moral (remaja yang bertanggung jawab), aspek pekerjaan (kewirausahaan);
 - b. Program untuk mencegah dan menanggapi masalah kesehatan reproduksi remaja antara lain: hubungan seks yang tidak terlindung, tidak dikehendaki (unprotected, unwanted sex), gizi buruk, kesehatan jasmani remaja, kehamilan remaja, abortus dan penyakit menular seksual (HIV/AIDS).

C. Model Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja di Puskesmas

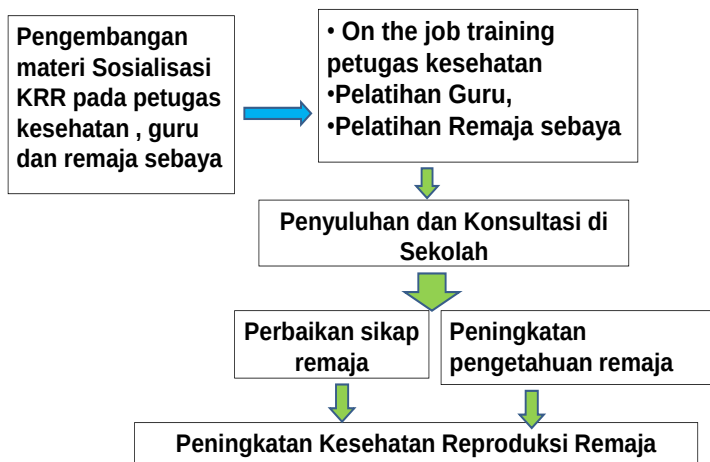
Hasil Penelitian Made Asri Budisuari dan Andriansyah Arifin (1999) tentang Model kesehatan reproduksi remaja (KRR) di 7 Kabupaten/kota (Kota Semarang, Surakarta dan Kabupaten Karang Anyar di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surabaya dan Malang di Jawa Timur, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung di provinsi Bali) pada tahun 1999 yang

meliputi 45 puskesmas, menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dilakukan oleh guru sekolah yang telah memperoleh informasi singkat tentang kesehatan reproduksi remaja dan oleh petugas puskesmas 1 tahun sekali pada remaja SMA saja sehingga didapatkan hasil bahwa 77.3% remaja kurang pengetahuannya tentang kespro, Remaja sangat sedikit memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten tentang hal-hal tersebut di atas. Sumber informasi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi sebagian besar 62,7% dari sumber yang kurang kompeten (ternan, saudara, majalah dan radio). Hal ini dapat mengakibatkan remaja kurang memiliki pengetahuan yang tepat tentang kesehatan reproduksinya dan dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang merugikan. Kegiatan penyuluhan yang belum dilakukan bagi remaja SMP baik oleh guru maupun petugas puskesmas dapat menyebabkan tidak adanya perubahan pengetahuan remaja SMP tentang kesehatan reproduksi. Belum dilakukannya penyuluhan ini karena adanya keterbatasan materi tentang kesehatan reproduksi bagi remaja SMP yang dimiliki guru, dan karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan oleh petugas puskesmas. Peiayanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas kurang banyak diminatidikunjungi oleh remaja. Hal ini karena persepsi remaja tentang puskesmas sebagai tempat berobat bagi yang sakit.

Model kesehatan reproduksi remaja diatas menekankan pada pemberian penyuluhan dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja dilakukan di sekolah oleh guru dan petugas kesehatan melalui pelatihan guru dan petugas kesehatan. Model ini mengharapkan adanya pengembangan materi kesehatan reproduksi yang lebih lengkap yang sesuai

dengan kebutuhan guru untuk memberikan penjelasan tentang kesehatan reproduksi baik bagi remaja SMP maupun bagi remaja SMA.

MODEL PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI PUSKESMAS



Sumber : Model Budisuari dan Arifin (2005)

Gambar 6.1. Model Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Puskesmas

D. Model Pemberdayaan Teman Sebaya (*Peer Empowerment*)

1. Pengertian Pemberdayaan Teman Sebaya

Pemberdayaan Teman Sebaya (*Peer Empowerment*) adalah suatu pendekatan yang berfokus pada peningkatan kemampuan individu melalui dukungan dan interaksi di antara kelompok teman sebaya. Dalam konteks ini, teman sebaya berfungsi sebagai agen pemberdayaan yang dapat membantu meningkatkan

keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran diri, serta memfasilitasi perubahan positif dalam kehidupan sesamanya.

2. Pengertian Model Pemberdayaan Teman Sebaya

Model Pemberdayaan Teman Sebaya adalah pendekatan yang menggunakan interaksi antar teman sebaya untuk meningkatkan kekuatan individu dan kelompok dalam mengatasi tantangan hidup, mencapai tujuan, serta memperbaiki kualitas hidup mereka. Dalam model ini, teman sebaya saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, serta memberikan dukungan emosional dan sosial. Model ini berfokus pada peningkatan kontrol individu atas kehidupan mereka, peningkatan kesejahteraan psikologis, dan penguatan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik.

3. Prinsip Dasar Model Pemberdayaan Teman Sebaya

- a. Kesetaraan dan Kolaborasi: Model ini menekankan hubungan yang setara antara individu dalam kelompok teman sebaya. Dalam konteks ini, tidak ada hierarki yang jelas, dan setiap individu dianggap memiliki nilai dan potensi yang sama untuk memberikan kontribusi.
- b. Pemberdayaan melalui Dukungan Sosial: Peer empowerment berfokus pada penciptaan jaringan dukungan sosial di antara teman sebaya. Dengan memberikan ruang bagi individu untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan, mereka merasa lebih dihargai dan diberdayakan.
- c. Keterlibatan Aktif: Dalam model ini, setiap individu diberi kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam proses pemberdayaan, baik sebagai penerima maupun

pemberi dukungan. Ini menciptakan rasa tanggung jawab dan keterlibatan yang lebih besar dalam pencapaian tujuan bersama.

4. Proses Pemberdayaan dalam Model Pemberdayaan Teman Sebaya

- a. Meningkatkan Keterampilan Sosial: Peer empowerment mengajarkan individu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan penyelesaian masalah. Dengan keterampilan ini, individu merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup mereka.
- b. Peningkatan Kepercayaan Diri dan Autonomi: Melalui proses pemberdayaan, individu merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kepercayaan diri ini berkembang melalui dukungan positif dari teman sebaya yang saling mendukung.
- c. Perubahan Sosial dan Individu: Model ini tidak hanya berfokus pada perubahan pada level individu, tetapi juga menciptakan perubahan sosial dalam kelompok atau komunitas. Ini bisa mencakup perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku yang lebih positif.

5. Manfaat Pemberdayaan Teman Sebaya

- a. Peningkatan Kesehatan Mental dan Emosional: Dengan adanya dukungan dari teman sebaya, individu merasa lebih dipahami dan didukung, yang dapat mengurangi perasaan kesepian, kecemasan, dan depresi.
- b. Peningkatan Kepercayaan Diri dan Pengembangan Identitas Positif: Model peer empowerment membantu individu membangun rasa percaya diri dan memperkuat identitas positif mereka, terutama di kalangan remaja dan orang muda.

- c. Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan: Melalui proses pemberdayaan, individu belajar untuk mengambil peran aktif sebagai pemimpin atau agen perubahan dalam kelompok mereka.
- d. Peningkatan Keterlibatan dalam Komunitas: Program peer empowerment dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam komunitas, yang menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung.

6. Tantangan dalam Model Pemberdayaan Teman Sebaya

- a. Kesulitan dalam Mengelola Dinamika Kelompok: Terkadang, ada tantangan dalam memastikan bahwa hubungan antar teman sebaya tetap sehat dan mendukung. Ketegangan atau perbedaan pendapat dalam kelompok bisa menghambat proses pemberdayaan.
- b. Keterbatasan dalam Pengetahuan atau Keterampilan Peer Educator: Peer educator harus dilatih dengan baik untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan efektif kepada teman sebaya mereka.
- c. Keterbatasan Dukungan dan Sumber Daya: Keberhasilan model ini sangat bergantung pada adanya dukungan berkelanjutan dari pihak yang lebih berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan program. Tanpa dukungan ini, program pemberdayaan teman sebaya bisa kurang efektif.

E. Pengembangan Model Pemberdayaan Teman Sebaya (*Peer Empowerment*) dalam Kesehatan Reproduksi Remaja

Pengembangan Model kesehatan reproduksi remaja ini menekankan pada optimalisasi peran teman sebaya sebagai peer educator dan pengembangan materi yang memadai untuk pegangan peer educator sehingga akan menjadi centra pendidikan dan konseling bagi remaja. Penerapan model ini bisa dilakukan di sekolah maupun luar sekolah dan memungkinkan penyampaian informasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja secara lebih efektif karena penyuluhan dapat dilakukan pada saat, kondisi dan waktu yang lebih fleksibel tidak tergantung dari batasan pekerjaan seperti pada guru dan petugas puskesmas. Metode pendekatan pendidikan sebaya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang atau kelompok orang yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi remaja dengan pemberdayaan teman sebaya (peer educator). Pendidikan kelompok sebaya dilaksanakan antar kelompok sebaya tersebut dengan dipandu oleh fasilitator yang juga berasal dari kelompok itu sendiri, sehingga diharapkan lebih efektif.

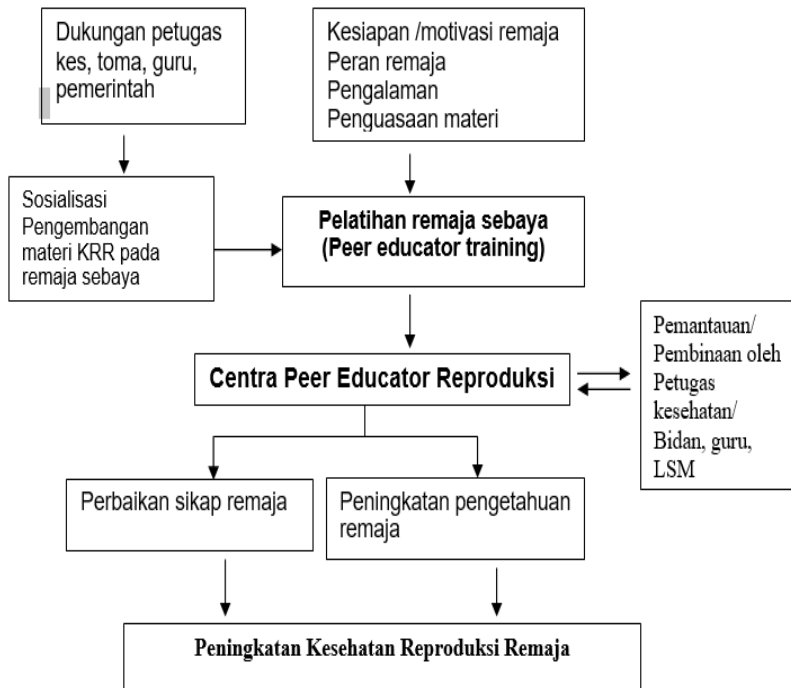
Model ini memerlukan kesiapan/motivasi remaja, peran remaja, pengalaman dan penguasaan materi tentang kesehatan reproduksi sehingga diperlukan sosialisasi pengembangan materi tentang KRR melalui suatu pelatihan-pelatihan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti tenaga kesehatan, guru, tokoh masyarakat dan pemerintah agar peran dan fungsi peer educator dapat lebih efektif dan berdayaguna sehingga menjadi pusat atau *Centra Peer Educator* Reproduksi. Dengan berbekal pengetahuan yang benar tentang

kesehatan reproduksi, remaja dapat menjadi sumber informasi bagi teman sebayanya sehingga diharapkan pengetahuan dan sikap atau perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi menjadi lebih baik.

Pelaksanaan model ini akan sulit mencapai hasil yang optimal tanpa pemantauan dan pembinaan oleh tenaga kesehatan, guru, bidan atau LSM. Kelompok remaja perlu mendapat dukungan secara terus menerus agar dapat menjadi pioner bagi peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan sebagai perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan, sehingga dengan demikian dapat membantu tugas tenaga kesehatan maupun guru sekolah dalam memberikan penyuluhan kepada remaja. Disamping itu kelompok Peer educator ini perlu mendapatkan masukan-masukan dan informasi baru terkait dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Secara garis besar, pengembangan Model Kesehatan Reproduksi remaja melalui pemberdayaan Teman Sebaya (*Peer Empowerment*) dapat dilihat pada bagan Gambar 6.2.

Hasil Pengembangan Model Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Pemberdayaan Teman Sebaya



Gambar 6.2 Pengembangan Model Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Optimalisasi Peran Teman Sebaya

BAB 7

PEDOMAN IMPLEMENTASI MODEL

Pedoman ini menggambarkan prosedur pelaksanaan model yang dipusatkan pada remaja sebagai *peer educator* bagi teman sebayanya untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Model ini dikembangkan dari model kesehatan reproduksi yang ada sebelumnya yaitu model kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas yang menekankan pada pemberian penyuluhan dan konseling di sekolah oleh nakes, dimodifikasi menjadi model yang memfokuskan pada remaja sebagai pusat pemberi penyuluhan kepada remaja melalui pendidikan/pelatihan *peer educator* sehingga diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi.

A. Tahapan Implementasi Model

Model ini terdiri dari 5 tahap penting agar dapat mencapai tujuan secara optimal, yaitu:

1. Seleksi *peer educator*, untuk mengetahui kesiapan remaja menjadi seorang educator dengan melihat motivasi remaja. Pada tahap ini perlu dilakukan penjarangan remaja menggunakan kuesioner tentang motivasi remaja, pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi. Evaluasi tingkat motivasi dinilai melalui kuesioner yang menggambarkan dorongan atau kebutuhan remaja untuk berprestasi, bergaul dan berkuasa/memimpin. Remaja yang ikut serta dalam penjarangan *peer educator* tidak ada persyaratan khusus,

namun dalam proses penjaringan remaja yang mempunyai motivasi tinggi dan alasan yang tepat dipilih untuk mengikuti pelatihan menjadi calon *peer educator*. Selama proses seleksi ini tidak ada unsur pemaksaan sehingga remaja yang berpartisipasi diberikan inform consent tentang kesediaan menjadi *peer educator*.

2. Pengembangan materi kesehatan reproduksi remaja, yang diperlukan oleh remaja untuk memberikan penyuluhan dan pemberian informasi kepada teman sebayanya agar informasi yang diberikan benar. Pada tahap ini perlu di susun materi tentang kesehatan reproduksi dan konsep *peer educator* dalam berbagai bentuk media antara lain modul, leaflet, poster, lembar balik atau permainan edukasi.
3. Pelatihan *peer educator* oleh tenaga kesehatan, untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan pada remaja tentang kesehatan reproduksi dan tugas sebagai *peer educator* sehingga informasi dapat diterima dengan mudah oleh teman sebayanya. Pada tahap ini remaja diberikan pelatihan selama 3 hari baik teori maupun praktik dan dilakukan test sebelum dan sesudah pelatihan. Remaja yang konsisten mengikuti pelatihan hingga selesai tanpa absen serta memberikan peningkatan hasil post test maka diikutkan dalam kegiatan selanjutnya yaitu aplikasi pelatihan dengan praktik memberikan penyuluhan atau edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja sebaya.
4. Pembentukan centra *peer educator*, sebagai pusat informasi remaja untuk memudahkan dalam pemantauan dan pembinaan oleh tenaga kesehatan atau guru. Pada tahap ini remaja yang telah dilatih (*Peer educator*) memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi

pada teman sebaya di sekolah secara kontinyu yaitu secara berkelompok, dimana setiap *peer educator* berkewajiban memberikan minimal satu topik materi kespro remaja, kemudian melakukan evaluasi tingkat pengetahuan dan sikap remaja.

5. Pemantauan dan pembinaan oleh tenaga kesehatan atau guru, yang diperlukan oleh *peer educator* untuk mendapatkan dukungan dan motivasi agar dapat berjalan secara kontinyu dan konsisten sebagai pusat *peer educator*.
6. Kerjasama lintas sektor antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, puskesmas/tenaga kesehatan, guru dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan terhadap keberlangsungan program pendidikan teman sebaya (*Peer education*).

B. Sarana dan Prasarana

Implementasi model ini memerlukan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelatihan *peer educator* antara lain gedung atau tempat pelatihan, fasilitas IT seperti LCD, proyektor dan media untuk pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi. Media dalam implementasi model ini dilengkapi dengan 1). modul pelatihan kesehatan reproduksi yang berisi tentang materi-materi kesehatan reproduksi remaja, antara lain tumbuh kembang remaja, anemia pada remaja, menstruasi dan mimpi basah, masa subur dan kehamilan, resiko kehamilan remaja, perilaku seksual, pelecehan seksual, pernikahan dini, NAPZA, aborsi dan PMS/HIVAIDS, 2). pedoman pendidik sebaya dan 3) beberapa media informasi seperti leaflet, poster, lembar balik untuk kegiatan pelatihan pendidik sebaya (*peer educator*). Media informasi ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan

remaja dan kemampuan remaja untuk berkreasi membuat media pembelajaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan model ini adalah perlu adanya dukungan yang baik dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan jajarannya (Puskesmas) untuk memfasilitasi pembentukan pusat-pusat *peer educator* dan pembinaan serta pemantauannya agar dapat berjalan dengan lancar dan konsisten, serta peran serta masyarakat seperti sekolah, tokoh masyarakat, dan keluarga. Tanpa dukungan dan peran serta masyarakat, maka pusat-pusat *peer educator* ini tidak dapat berjalan secara optimal.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat memberikan gambaran tentang langkah-langkah implementasi model, dengan harapan model ini dapat diterapkan dengan mudah dan jelas.

C. Hasil Implementasi Model

Pengembangan model kesehatan reproduksi remaja melalui pemberdayaan teman sebaya memberikan kerangka dalam mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Partisipasi remaja dan dukungan masyarakat memberikan kontribusi terhadap hasil penerapan model ini terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi. Implementasi model menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Motivasi, kemauan dan kemampuan remaja sebagai *peer educator* menunjukkan tidak ada satu orang remaja pun yang mempunyai motivasi rendah. Remaja memiliki potensi untuk berkarya dan mengembangkan diri. Hasil ini sesuai dengan pendapat Widyanoro dan Lestari (2003), bahwa motivasi berprestasi dan bergaul merupakan modal utama sebagai seorang calon *peer*

educator untuk bisa melaksanakan perannya sebagai *peer educator*. Seorang pendidik sebaya harus peka, berpikiran terbuka, pendengar yang baik, penghubung yang baik dan memiliki interpersonal yang baik. Seorang pendidik sebaya juga harus mengembangkan kepemimpinan dan motivasi keterampilan. Hasil ini menunjukkan bahwa ada kesiapan remaja untuk menjadi pendidik sebaya karena hal ini sangat diperlukan untuk dapat menjadi sumber informasi bagi teman sebayanya.

2. Tingkat pengetahuan remaja sebelum mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi oleh teman sebayanya terbanyak pada kategori cukup baik dan beberapa remaja memiliki pengetahuan yang kurang, sedangkan setelah mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi oleh teman sebayanya secara bermakna meningkatkan pengetahuan pada kategori baik ($p\text{value}=0,00$). Hal ini dimungkinkan karena faktor KIE yang diberikan oleh kelompok *peer educator*. Dalam pemberian informasi ini kelompok *peer educator* menggunakan media/alat bantu yang dibuat oleh kelompok sendiri, menggunakan bahasa sederhana yang mudah diterima oleh remaja dan pelaksanaan KIE dilakukan di luar jam pelajaran di tempat yang nyaman dan dalam suasana yang rileks. Posisi *peer educator* duduk berhadapan dengan remaja dalam posisi melingkar, sehingga sangat efektif untuk melakukan komunikasi dua arah. Jumlah remaja dalam tiap kelompok adalah 9-10 orang, sehingga akan lebih efektif untuk bisa memberikan informasi. Selama penyuluhan interaksi terjadi secara aktif dan partisipasi remaja untuk berdiskusi baik. Hal ini menunjang teori yang disampaikan oleh (Elisa et al., 2012) bahwa *peer education* merupakan salah satu

metode yang paling sering digunakan untuk pelaksanaan intervensi promosi kesehatan pada remaja.

3. Sikap remaja tentang kesehatan reproduksi sebelum dan setelah pemberian penyuluhan oleh *peer educator* menunjukkan sikap yang positif atau baik yaitu sebagian besar bersikap tidak mendukung perilaku seks bebas dan pernikahan dini, dengan perbedaan nilai rata-rata 9,33 dan secara signifikan menunjukkan adanya perbedaan antara remaja yang mendapat penyuluhan oleh guru atau tenaga kesehatan dengan *peer educator* ($p=0,000$). Remaja yang mendapat penyuluhan oleh *peer educator* mengalami proses belajar yang lebih menyenangkan dan mudah diterima sehingga memberikan kontribusi terhadap perubahan sikap, sedangkan remaja yang mendapatkan penyuluhan dengan guru atau tenaga kesehatan memungkinkan mengalami perubahan sikap yang agak lama karena informasi atau penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dilakukan belum intensif sehingga proses internalisasi pada diri remaja kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Budisuari & Arifin, 2005) bahwa intervensi berupa penyuluhan yang dilakukan oleh guru SMA yang telah memperoleh informasi singkat tentang kesehatan reproduksi remaja dan penyuluhan secara terbatas 1 kali setahun yang dilakukan oleh petugas puskesmas bagi remaja di SMA dan bagi remaja di luar sekolah dan kegiatan penyuluhan yang belum dilakukan bagi remaja SMP baik oleh guru maupun petugas puskesmas dapat menyebabkan tidak adanya perubahan pengetahuan remaja SMP tentang kesehatan reproduksi.

BAB 8

PENUTUP

Buku monograf ini memiliki beberapa tujuan yang dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi remaja.

Tujuan penulisan ini meliputi: 1). Memberikan informasi ilmiah yang komprehensif tentang model kesehatan reproduksi remaja yang memfokuskan pada remaja sebagai pusat pemberi penyuluhan kepada remaja melalui pendidikan atau pelatihan pendidik sebaya (*peer educator*) dengan menyajikan data dan informasi berdasarkan penelitian. 2). Memberikan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan atau Puskesmas dalam manajemen pengelolaan kesehatan reproduksi remaja (KRR) dalam upaya meningkatkan kesehatan remaja. 3). Mengembangkan model pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang telah ada untuk memberikan kerangka dalam memahami dan mengembangkan praktek pelayanan kesehatan reproduksi khususnya pada remaja melalui penelitian. 4). Mendorong penelitian bidang kesehatan reproduksi serta merangsang inovasi dalam pelayanan kesehatan, 5). Menjadi rujukan atau referensi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi khususnya pada remaja.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan pengetahuan dan praktik di bidang kesehatan reproduksi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja

untuk memelihara kesehatan reproduksinya serta berperan secara aktif memberikan edukasi kesehatan kepada teman sebaya sehingga mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan reproduksi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A., Mursalat, A., Kusnadi, I., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurohim. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In Afriansyah (Ed.), *Padang*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Azizah, RE, Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan, tersedia di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/>, KPKNL Pontianak diposting tanggal 16 Desember 2022, diakses tgl 14-12-2024
- Azwar, S., 1995, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Al-Iryani, B., Basaleem, H., Al-Sakkaf, K., Kok, G., & van den Borne, B. (2013). Process evaluation of school-based peer education for HIV prevention among Yemeni adolescents. *Journal Des Aspects Sociaux Du*, 10(1), 55–64.
- BKKBN, STARH, USAID. 2003. Pubertas dan Kematangan Seksual Pada Remaja. *edisi 2*
- Budisuari, M., & Arifin, A. (2005). Pengembangan Model Kesehatan Reproduksi Remaja-(KRR). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 8 (Juni), 40–46.
- Chavez, V., & Duran, B. (2003). "Peer Education as a Strategy for Social Change." *Journal of Community Practice*, 11(4), 45-57.
- Daryanti, E., dan Marlina, L., (2021). Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Langgam Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=fbdVEAAAQBAJ>

Depkes RI. 2001. Yang Perlu Diketahui Tentang Kesehatan Reproduksi. Jakarta

Departemen Kesehatan RI, Penggerakan Pendidikan Kelompok Sebaya Dalam Menanggulangi HIV/ AIDS dan PMS lainnya di Tempat Kerja, *Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat*, 1996/1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Pelatihan dan Modul Pendidikan Sebaya dalam Rangka Pendidikan Pencegahan HIV/AIDS di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 1997.

Elisa, L., Maria, F., Gabriella, C. M., Luciano, M., & Vito, E. De. (2012). An Experience in the Prevention of HPV by and for Adolescents: A Community Randomized Trial of the Effect of Peer Health Education on Primary Prevention in a 1-Year Follow Up. *Creative Education*, 03 (06), 1138–1149. <https://doi.org/10.4236/ce.2012.326170>

Eirene E.M, dkk (2012). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Persepsi Perilaku Seks Bebas Pada Siswa Smu Negeri Kota Malang. *Jurnal Penelitian FK –UB Malang*. Tersedia di old.fk.ub.ac.id/artikel/id/filedownload/keperawatan/eirene. diakses tgl 10 Maret 2014.

European Humanist Federation. (2015). What Are Sexual And Reproductive Health and Rights? *European Humanist Federation*, January. www.humanistfederation.eu

Strange, V., Forrest, S., & Oakley, A. (2002). What influences peer-led sex education in the classroom? A view

- from the peer educators. *Health Education Research*, 17(3), 339–349.
<https://doi.org/10.1093/her/17.3.339>
- Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, M., & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, M. R. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak* (No 1 dan 329 tahun 2023).
- Elisa, E., Salma Adilanisa, Dina Indrati, Muhamad Jauhar, & Maksuk, M. (2022). Peer Education Improve Knowledge and Attitude About Sexual Behavior in Adolescents: A Literature Review. *International Journal of Advanced Health Science and Technology*, 2(6), 431–436.
<https://doi.org/10.35882/ijahst.v2i6.191>
- Galbinur, E., Defitra, M. A., & Venny. (2021). Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. *Prosiding SEMNAS BIO*, 221–228.
<https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/pentingnya-pengetahuan-kesehatan-reproduksibagi-remaja.html>
- Graham, P., & Peters, J. (2008). "Peer-led health education: A systematic review." *Health Education Research*, 23(4), 662–670.
- Hasdiansyah, A. (2023). Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat. In *Purbalingga* (Pertama). CV. Eureka Media Aksara.
- ICPD. 1994. Konferensi Kependudukan Sedunia Pada Program Kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Kairo*
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 14

Desember. 2024. <https://kbbi.web.id/didik>

- Kieffer, C. H. (1984). "Citizen empowerment: A developmental perspective." *Prevention in Human Services*, 3(2), 9-36.
- Lapu, Yuven Merdiaris, 2010."Kenakalan Remaja".[online] http://sabdaspace.com/kenakalan_remaja. (diaksespada tanggal 26 Juni 2010).
- Lorenz, F. Q. Q., & Permatasari, H. (2023). Implementasi Peer Education dalam Meningkatkan Pengetahuan Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(2), 1817–1826. <https://doi.org/10.31539/jks.v6i2.5867>
- Mabuie, M. A. (2020). Role of peer educators in behaviour change communication interventions for HIV prevention among people who inject drugs: Systematic review article. *Technium Social Sciences Journal*, 10(August), 189–200.
- Manuaba, Gde.1999. Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita. Arcan : Jakarta
- Maryam, A., Santy, P., Sekarpuri, AD., Rachmad, SH., Muaningsih, Nua, EN., Ekacahyaningtyas, M., Nusdin, S., dan Mappaware, NA., (2021). Perempuan dan Permasalahannya dalam Sistem Reproduksi. Bandung. CV Media Sains Indonesia
- Mason-Jones, A. J., Flisher, A. J., & Mathews, C. (2011). Who are the peer educators? HIV prevention in South African schools. *Health Education Research*, 26(3), 563–571. <https://doi.org/10.1093/her/cyq064>
- Matahari, R., (2018). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Infeksi

Menular Seksual. Pustaka Ilmu.
<https://books.google.co.id/books?id=6mINEAAQBJ>

- Munajat, N. (2000). Modul Kerelawanan. Jakarta. PKBI, IPPF, BKKBN, UNFPA
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmojo, S., 1993, Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nurgina, S., Kuswana, D., & Rahmawaty, I. S. (2023). Pemberdayaan Perempuan melalui Perempuan Kepala Keluarga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 21–42.
<https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i1.23943>
- Nurmala, I., Li, C. Y., Pertiwi, E. D., Devi, Y. P., Muthmainnah, M., & Rachmayanti, R. D. (2022). The Correlation between Self-Efficacy, Grade, and Sex on the Intention to Participate in Peer-Education Activities in Drug Abuse Prevention. *Iranian Journal of Public Health*, 51(3), 702–704.
<https://doi.org/10.18502/ijph.v51i3.8951>
- Nursalam. 2008. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika
- Peykari, N., Ramezani Tehrani, F., Malekafzali, H., Hashemi, Z., & Djalalinia, S. (2011). An experience of peer education model among medical science university students in Iran. *Iranian Journal of Public Health*, 40(1), 57–62.
- Ranjbar, H., Sadeghi-Vazin, K., & Bakhshi, M. (2024). The cost-

effectiveness of peer education on medication adherence in the elderly with hypertension: a randomized controlled trial. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20807-z>

Sandhu, S., Veinot, P., Embuldeniya, G., Brooks, S., Sale, J., Huang, S., Zhao, A., Richards, D., & Bell, M. J. (2013). Peer-to-peer mentoring for individuals with early inflammatory arthritis: Feasibility pilot. *BMJ Open*, 3(3), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2012-002267>

Saputro, A., Ford, N. J., Shaluhayah, Z. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja di Jawa Tengah Implikasinya Terhadap Kebijakan dan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, (online), ([http://www.journal ui.ac.id//diakses](http://www.journal.ui.ac.id//diakses) pada tanggal 10 Maret 2014

Siregar, R., Rosramadhana, Zulaini, Iqbal, M., Sari, P., Rachmah, S., & Sudirman. (2022). *Model Pemberdayaan Perempuan*. CV. Pena Persada. <https://www.researchgate.net/publication/362252947>

Subuh, HM, 2012, Epidemiologi HIV-AIDS di Indonesia, Ditjen PP&PL Kementerian Kesehatan RI

Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sutami, B., Rozikin, M., & Yumarni, T. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perindungan Anak Melalui Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 7(4), 194–200.

Sutisna, A. (2013). Model Pemberdayaan Perempuan Dan

- Pengarusutamaan Gender Melalui Layanan Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Cakrawala Pendidikan*, 3(November), 470-479.
- Swartz, S., Deutsch, C., Makoe, M., Michel, B., Harding, J. H., Garzouzie, G., Rozani, A., Runciman, T., & Van der Heijden, I. (2012). Measuring change in vulnerable adolescents: Findings from a peer education evaluation in South Africa. *Sahara J*, 9(4), 242-254. <https://doi.org/10.1080/17290376.2012.745696>
- Stewart, M., & Thomas, D. (2019). "Peer-led Health Education: A Strategy for Social Change." *Community Development Journal*, 54(1), 55-72
- Tanjung, A, Utamadi, G, Sahanaja, J.2003.Kebutuhan Akan Informasi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja : *Laporan Need Assesment di Kupang,Palembang, Singkawang, Cirebon dan Tasikmalaya (revisi)*. PKBI, BKKBN dan UNFPA : Jakarta.
- Tindall, L., & Gorman, M. (2009). "Building Capacity in Peer Education: Lessons Learned from HIV/AIDS Programs." *Journal of Community Practice*, 17(2), 210-228.
- United Nations. (1994). Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September. In *United Nations New York*.
- Walgito. (2003). *Sikap*. Bandung: Swarna Rupa
- Wawrzynski, M. R., LoConte, C. L., & Straker, E. J. (2011). Learning outcomes for peer educators: The national survey on peer education. *New Directions for Student*

Services, 2011(133), 17–27.
<https://doi.org/10.1002/ss.381>

- WHO, (1992) Pendidikan Kesehatan (Diterjemahkan Glen ida Bagus Tjitarsa), Penerbit ITB dan Universitas Udayana, Bandung.
- Widyantoro, N dan Lestari, H. (2014). Panduan Pendidik Sebaya Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi. Cetakan kedua. *Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP)*. Jakarta.
- Zahan, N. (2014). Factors Influencing Women's Reproductive Health. *ABC Journal of Advanced Research*, 3(2), 105–114. <https://doi.org/10.18034/abcjar.v3i2.36>
- Zimmerman, M. A. (2000). "Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and Community Levels of Analysis." In *Handbook of Community Psychology* (pp. 43-63). Springer.
- Jawa Timur Rangking Kedua Jumlah Kasus HIV/AIDS Terbanyak, tersedia di <http://www.igama.or.id/2013/03/jawa-timur-rangking-kedua-jumlah-kasus-hivaidst-terbanyak/>, diakses tgl 8 -3-2013

GLOSARIUM

A

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome): Kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan.

F

Free sex: seks bebas

Female Genital Mutilation (FGM): Semua prosedur yang melibatkan penghilangan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan, atau cedera lain pada organ genital perempuan untuk alasan non-medis.

P

Peer educator: Pendidik sebaya

Peer education: Pendidikan Sebaya

Peer empowerment : Pemberdayaan Teman sebaya

H

HIV (Human Immuno Deficiency Virus): Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit.

I

ICPD (International Conference on Population and Development): Konferensi internasional yang diselenggarakan di Kairo tahun 1994 yang membahas tentang isu kependudukan dan pembangunan yang menempatkan martabat dan hak asasi manusia sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan dan diakui hak-hak reproduksi perempuan.

O

Obesitas: kondisi berat badan melebihi batas normal karena adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh.

PROFIL PENULIS



Dr. Heny Astutik, S.Kep., Ns., M.Kes., Lahir di Malang, 21 Juni 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai jenjang D3 Keperawatan AKPER Depkes Malang lulus tahun 1991, kemudian menempuh pendidikan bidan PPB-B Kebidanan PAM Keperawatan Keguruan Soetopo Surabaya lulus tahun 1995, kemudian melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia di Jakarta lulus tahun 2002. Kemudian kembali melanjutkan pendidikan bidan D3 Kebidanan Poltekkes Depkes Soetomo Surabaya lulus tahun 2005. Penulis mengambil program Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Kesehatan Reproduksi Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2010 serta menyelesaikan Program Doktorat Ilmu Kedokteran-minat Reproduksi di FK Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2019. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Malang Jurusan Kebidanan, mengampu mata kuliah Askeb persalinan dan bayi baru lahir, Askeb KB dan Kesehatan Reproduksi, Askeb Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, Genetika dan Biologi Reproduksi, Farmakologi serta Biostatistik. Selain aktif sebagai dosen, juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, nara sumber atau pembicara dalam kegiatan seminar atau konferensi internasional maupun peserta, penelitian dan reviewer etik. Semoga buku yang kami tulis bermanfaat untuk kaum akademisi dan masyarakat pada umumnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: heny_astutik@poltekkes-malang.ac.id

Motto: "Ora et Labora"

PROFIL PENULIS



Dr. Roni Yuliwar, S.Kep., Ns., M.Ked., Lahir di Pekanbaru, 11 Juli 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai jenjang D3 Keperawatan AKPER Depkes Padang lulus tahun 1992, kemudian menempuh pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia di Jakarta lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan program Magister S2 pada program studi Ilmu Kedokteran Dasar Universitas Airlangga (UNAIR) dan lulus pada tahun 2010. Kemudian menyelesaikan Program Doktor Ilmu Kedokteran-minat Ilmu Kedokteran Dasar di FK Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1993 sebagai asisten dosen di Akper Payung Negeri Pekanbaru kemudian pada tahun 1995 bekerja di SPK Negeri Tanjungpinang, tahun 2003 bekerja di Poltekkes Depkes RI Tanjungpinang. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Malang Jurusan Teknologi Bank Darah mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi, Patofisiologi, Komunikasi, Seleksi Pendonor, Basic Life Support, Manajemen Bencana dan Statistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian, pengabdian masyarakat dan reviewer etik. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: r.yuliwar@gmail.com.

Motto: "Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain"

SINOPSIS BUKU

Pendidikan kesehatan reproduksi dapat dilakukan oleh orang tua, guru, bidan, pemerhati remaja termasuk oleh remaja sendiri, karena remaja juga memiliki potensi untuk berkarya, menjadi pendidik sebaya dan sahabat remaja karena mereka lebih mudah diterima oleh kaum remaja.

Buku ini menguraikan Model Kesehatan Reproduksi Remaja yang memfokuskan remaja sebagai pendidik sebaya (*Peer educator*) yang merupakan pengembangan dari model kesehatan reproduksi yang telah ada, konsep kesehatan reproduksi remaja dan pendidikan teman sebaya beserta pedoman implementasinya. Penerapan model ini sering digunakan dalam konteks pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, pengembangan pribadi, dan pemberdayaan masyarakat khususnya remaja.

Isi buku disusun sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, remaja, pengelola pelayanan kesehatan, peserta didik kesehatan, tenaga kesehatan dan kaum akademisi.

Pendidikan kesehatan reproduksi dapat dilakukan oleh orang tua, guru, bidan, pemerhati remaja termasuk oleh remaja sendiri, karena remaja juga memiliki potensi untuk berkarya, menjadi pendidik sebaya dan sahabat remaja karena mereka lebih mudah diterima oleh kaum remaja.

Buku ini menguraikan Model Kesehatan Reproduksi Remaja yang memfokuskan remaja sebagai pendidik sebaya (Peer educator) yang merupakan pengembangan dari model kesehatan reproduksi yang telah ada, konsep kesehatan reproduksi remaja dan pendidikan teman sebaya beserta pedoman implementasinya. Penerapan model ini sering digunakan dalam konteks pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, pengembangan pribadi, dan pemberdayaan masyarakat khususnya remaja.

Isi buku disusun sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, remaja, pengelola pelayanan kesehatan, peserta didik kesehatan, tenaga kesehatan dan kaum akademisi.

Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919

